



**ReMaP**  
Redesenho da Rede de  
Atenção Materna e Perinatal

## Documentação dos Indicadores

Painel do Projeto ReMaP

(Reestruturação e Redesenho da Rede Materna e Perinatal do Estado de São Paulo)

(10/03/2026)

## Sumário

|                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">Sobre este arquivo.....</a>                                                  | <a href="#">3</a>  |
| <a href="#">Glossário.....</a>                                                           | <a href="#">3</a>  |
| <a href="#">1. Estatísticas RRAS</a>                                                     |                    |
| <a href="#">1.1 Atenção Primária à Saúde.....</a>                                        | <a href="#">4</a>  |
| <a href="#">1.1.1 Nascidos Vivos.....</a>                                                | <a href="#">4</a>  |
| <a href="#">1.1.2 Gestantes SUS Dependentes Estimadas.....</a>                           | <a href="#">5</a>  |
| <a href="#">1.1.3 Nascidos Vivos SUS Dependentes Estimados.....</a>                      | <a href="#">6</a>  |
| <a href="#">1.1.4 Cobertura de Saúde Suplementar (ANS).....</a>                          | <a href="#">8</a>  |
| <a href="#">1.1.5 Cobertura Populacional com Equipes de Saúde da Família (ESF).....</a>  | <a href="#">9</a>  |
| <a href="#">1.1.6 Cobertura de Atenção Básica Municipal (AB).....</a>                    | <a href="#">10</a> |
| <a href="#">1.1.7 Número de Unidades Básicas de Saúde (UBS).....</a>                     | <a href="#">11</a> |
| <a href="#">1.2 Estabelecimentos de Referência.....</a>                                  | <a href="#">12</a> |
| <a href="#">2. Óbitos de Gestantes e Puérperas</a>                                       |                    |
| <a href="#">2.1 Séries de Mortalidade e Morbidade.....</a>                               | <a href="#">14</a> |
| <a href="#">2.1.1 Número de óbitos maternos.....</a>                                     | <a href="#">14</a> |
| <a href="#">2.1.2 Razão de Mortalidade Materna (RMM) por 100.000 nascidos vivos.....</a> | <a href="#">15</a> |
| <a href="#">2.1.3 Porcentagem de óbitos maternos por causas obstétricas diretas.....</a> | <a href="#">16</a> |
| <a href="#">2.1.4 Porcentagem de óbitos maternos diretos por causas específicas.....</a> | <a href="#">17</a> |
| <a href="#">2.2 Oficiais.....</a>                                                        | <a href="#">18</a> |
| <a href="#">2.2.1 Tabela de Óbitos Maternos Oficiais.....</a>                            | <a href="#">18</a> |
| <a href="#">2.3 Não considerados.....</a>                                                | <a href="#">19</a> |
| <a href="#">2.3.1 Tabela de Óbitos Não Considerados.....</a>                             | <a href="#">19</a> |
| <a href="#">2.4 Análise Cruzada.....</a>                                                 | <a href="#">20</a> |
| <a href="#">3. Indicadores Obstétricos</a>                                               |                    |
| <a href="#">3.1 Partos Prematuros.....</a>                                               | <a href="#">22</a> |
| <a href="#">3.1.1 Nascimentos.....</a>                                                   | <a href="#">22</a> |
| <a href="#">3.1.2 Partos Prematuros.....</a>                                             | <a href="#">22</a> |
| <a href="#">3.1.3 Partos Cesáreas.....</a>                                               | <a href="#">24</a> |
| <a href="#">3.1.4 Porcentagem de partos cesáreos.....</a>                                | <a href="#">24</a> |
| <a href="#">3.2 Anomalias congênitas.....</a>                                            | <a href="#">25</a> |
| <a href="#">3.3 Consultas de pré-natal.....</a>                                          | <a href="#">26</a> |
| <a href="#">3.4 Robson.....</a>                                                          | <a href="#">27</a> |
| <a href="#">3.5 Robson e cesáreas.....</a>                                               | <a href="#">28</a> |

## Sobre este arquivo

O presente documento contém a documentação dos indicadores disponíveis no Painel ReMaP (atualizada em 10/03/2025). Nele, estão descritas as definições, métodos de cálculo, fontes de dados, informações sobre a qualidade da informação e as referências utilizadas na construção de cada indicador.

Os indicadores foram calculados para o período de 2012 a 2024, com atualizações periódicas previstas conforme a disponibilização de novos dados.

O painel tem como foco principal o Estado de São Paulo, permitindo a análise dos indicadores em diferentes níveis territoriais, incluindo Estado, Departamentos Regionais de Saúde (DRS), Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), Regiões de Saúde e municípios.

## Glossário

RRAS – Redes Regionais de Atenção à Saúde

DRS – Departamentos Regionais de Saúde

SINASC – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

SISAB – Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica

ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar

SES – Secretaria de Saúde

OMS – Organização Mundial da Saúde

CCD - Centro de Controle de Doenças

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

SCNES - Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

## 1. Estatísticas RRAS

### 1.1 Atenção Primária à Saúde

#### 1.1.1 Nascidos Vivos

- **Definição:** número de nascidos vivos, conforme definição do Ministério da Saúde:  
“Produto da concepção que, após a separação completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gestação, respira ou apresenta outros sinais de vida, como batimentos cardíacos, pulsação do cordão umbilical ou movimentação dos músculos voluntários, mesmo que venha a falecer logo após o nascimento.” (Ministério da Saúde, SINASC; OMS, CID-10)
- **Método de cálculo:** contagem absoluta do número de nascidos vivos registrados no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), considerando o município de residência da mãe.
- **Fonte:** TabNet – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP), com base nos dados do SINASC/CCD/SES-SP – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos / Centro de Controle de Doenças da SES-SP. Ano de referência: 2023.
- **Qualidade da informação:** A base de dados é consolidada e validada pelo Centro de Controle de Doenças (CCD/SES-SP), a partir dos registros do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), conforme as normativas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os dados apresentam abrangência estadual e elevada confiabilidade, contemplando todos os municípios do Estado de São Paulo. A atualização ocorre periodicamente, de acordo com o cronograma de consolidação do SINASC pela SES-SP, garantindo padronização segundo protocolos nacionais e internacionais. Podem ocorrer subnotificações ou atrasos na inclusão de registros, especialmente em nível municipal.  
As informações foram extraídas em 24 de novembro de 2024. Conforme indicado no TabNet, os dados referentes ao período de 2022 a 2024 são preliminares e estão sujeitos a revisão até sua consolidação final.
- **Referências:**  
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. TabNet - Indicadores de Saúde. Disponível em:

<https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/profissional-da-saude/informacoes-de-saude-/tabnet-ses-indicadores-de-saude>

Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/sistemas-de-informacao/sinasc>

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD). Disponível em:

<https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/coordenadorias/coordenadoria-de-controle-de-doencas-ccd>

### 1.1.2 Gestantes SUS Dependentes Estimadas

- **Definição:** A estimativa de gestantes SUS dependentes corresponde ao número estimado de mulheres grávidas cuja assistência pré-natal, parto e puerpério é realizada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa estimativa baseia-se em parâmetros assistenciais do SUS e na lógica de organização regional da atenção materna, conforme diretrizes estabelecidas nas Portarias nº 650/2011 (Rede Cegonha) e nº 1.631/2015, sendo utilizada como aproximação da população potencial usuária do SUS para fins de planejamento da rede assistencial.
- **Método de cálculo:** Gestantes SUS dependentes estimadas = (Nascidos vivos × 1,10) × [1 – cobertura de saúde suplementar]. O fator 1,10 representa acréscimo de 10% sobre o número de nascidos vivos, ajustando para perdas fetais, abortos e subnotificações.
- **Fonte:** TabNet – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP), a partir dos dados do SINASC/CCD/SES-SP – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos / Centro de Controle de Doenças da SES-SP. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – Beneficiários de planos de saúde. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Estimativas populacionais. Ano de referência: 2023.
- **Qualidade da informação:** A base de dados é consolidada e validada pelo Centro de Controle de Doenças (CCD/SES-SP), a partir dos registros do SINASC, conforme as normativas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os dados possuem abrangência estadual e alta confiabilidade, abrangendo todos os municípios do Estado de São Paulo.

A atualização ocorre periodicamente, de acordo com o cronograma anual de consolidação do SINASC pela SES-SP, garantindo padronização segundo protocolos nacionais e

internacionais.

Podem ocorrer subnotificações ou atrasos na inclusão de registros, especialmente em nível municipal.

As informações foram extraídas em 24 de novembro de 2024. Conforme o TabNet, os registros de 2022 a 2024 são preliminares e poderão sofrer ajustes até a consolidação.

- **Referências:**

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. TabNet - Indicadores de Saúde. Disponível em:

<https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/profissional-da-saude/informacoes-de-saude-/tabnet-ses-indicadores-de-saude>

Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/sistemas-de-informacao/sinasc>

Organização Mundial da Saúde (OMS). Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10). Disponível em:

<https://www.who.int/classifications/icd/en/>

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 650, de 5 de outubro de 2011. Dispõe sobre os Planos de Ação Regionais e Municipais da Rede Cegonha. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em:

[https://bvsms.saude.gov.br/bvs/sas/Links%20finalizados%20SAS%202011/prt0650\\_05\\_10\\_2011.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/sas/Links%20finalizados%20SAS%202011/prt0650_05_10_2011.html)

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.631, de 1º de outubro de 2015. Aprova critérios e parâmetros para o planejamento e programação de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

### 1.1.3 Nascidos Vivos SUS Dependentes Estimados

- **Definição:** estimativa do número de nascidos vivos cuja assistência ao parto ocorreu no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), utilizada como aproximação da população potencialmente dependente do SUS para o cuidado obstétrico. O indicador permite dimensionar a demanda potencial por serviços obstétricos no SUS, com possibilidade de análise por Estado de São Paulo, RRAS, DRS, Regiões de Saúde e municípios, conforme os filtros disponíveis no Painel ReMaP, apoiando o planejamento e a organização regional da rede assistencial.

- **Método de cálculo:** Nascidos vivos SUS dependentes estimados = Nascidos vivos × [1 – cobertura de saúde suplementar/100]. A cobertura de saúde suplementar corresponde ao percentual da população beneficiária de planos de saúde, utilizado como aproximação da população não usuária exclusiva do SUS.
- **Fonte:** TabNet – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP), com base nos dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – beneficiários de planos de saúde. Ano de referência: 2023.
- **Qualidade da informação:** a base de dados é gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, com dados provenientes do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), amplamente utilizado para monitoramento da saúde materna e infantil no Brasil. Os dados apresentam abrangência estadual e são atualizados periodicamente, seguindo normativas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). A estimativa depende da qualidade do registro de nascidos vivos e das informações sobre cobertura de saúde suplementar, podendo sofrer influência de subnotificação ou atrasos na atualização das bases, especialmente em nível municipal.
- **Referências:**  
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. TabNet - Indicadores de Saúde. Disponível em:  
<https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/profissional-da-saude/informacoes-de-saude/tabnet-ses-indicadores-de-saude>  
 Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/sistemas-de-informacao/sinasc>  
 Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Dados de beneficiários de planos de saúde. Disponível em:  
<https://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor> Organização Mundial da Saúde (OMS). Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10). Disponível em: <https://www.who.int/classifications/icd/en/>  
 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 650, de 5 de outubro de 2011. Dispõe sobre os Planos de Ação Regionais e Municipais da Rede Cegonha. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em:  
[https://bvsms.saude.gov.br/bvs/sas/Links%20finalizados%20SAS%202011/prt0650\\_05\\_10\\_2011.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/sas/Links%20finalizados%20SAS%202011/prt0650_05_10_2011.html)

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.631, de 1º de outubro de 2015. Aprova critérios e parâmetros para o planejamento e programação de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

#### 1.1.4 Cobertura de Saúde Suplementar (ANS)

- **Definição:** percentual da população residente beneficiária de planos de saúde de assistência médica, em relação à população total.
- **Método de cálculo:** Cobertura de saúde suplementar = (Número de beneficiários de planos de saúde / população total residente) × 100
- **Fonte:** TabNet – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP). Ano referência: 2023.
- **Qualidade da informação:** os dados são provenientes de registros administrativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sistematizados e disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo por meio do TabNet. Apresentam abrangência estadual, com detalhamento por municípios, e são atualizados periodicamente conforme a disponibilização das bases oficiais.  
Por se tratar de dados administrativos, podem ocorrer pequenas inconsistências decorrentes de atualizações cadastrais, vínculos múltiplos de beneficiários ou defasagens temporais entre as bases de dados.
- **Referências:**  
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. TabNet - Indicadores de Saúde. Cobertura pela saúde suplementar. Disponível em:  
[https://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind47a\\_matriz.def](https://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind47a_matriz.def)  
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Dados e indicadores do setor. Disponível em: <https://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor>  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Nota técnica: Relatório de cobertura da Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: [https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/nota\\_tecnica/nota\\_tecnica\\_relatorio\\_de\\_cobertura\\_AB.pdf](https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/nota_tecnica/nota_tecnica_relatorio_de_cobertura_AB.pdf)  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Nota metodológica: Novo método de cálculo do indicador de cobertura populacional estimada na Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em:

[https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/nota\\_tecnica/nota\\_metodologica\\_AB.pdf](https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/nota_tecnica/nota_metodologica_AB.pdf)

### 1.1.5 Cobertura Populacional com Equipes de Saúde da Família (ESF)

- **Definição:** percentual da população residente coberta por equipes de Saúde da Família (ESF), considerando a estimativa de população adscrita a essas equipes no território.
- **Método de cálculo:** Cobertura populacional por ESF =  $(\text{População estimada coberta por equipes de Saúde da Família} / \text{população total residente}) \times 100$   
A população coberta é estimada a partir do número de equipes de Saúde da Família implantadas, considerando parâmetros definidos pelo Ministério da Saúde para população adscrita por equipe.
- **Fonte:** Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), com base em parâmetros do Ministério da Saúde. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – estimativas populacionais. TabNet – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP). Ano de referência: 2020.
- **Qualidade da informação:** os dados são provenientes de sistemas oficiais do Ministério da Saúde, especialmente o SCNES e o SISAB, e são amplamente utilizados para monitoramento da Atenção Primária à Saúde no Brasil. A estimativa de cobertura é baseada em parâmetros normativos de população adscrita por equipe, podendo não refletir integralmente a cobertura real da população.  
Podem ocorrer inconsistências relacionadas ao cadastro de equipes, defasagens na atualização das bases ou diferenças na implementação local das equipes de saúde.
- **Referências:**  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. e-Gestor Atenção Básica: histórico de cobertura da Atenção Básica. Disponível em:  
<https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml>  
Ministério da Saúde. Nota técnica - relatório de Cobertura da Atenção Básica. Disponível em:  
[https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/nota\\_tecnica/nota\\_tecnica\\_relatorio\\_de\\_cobertura\\_AB.pdf](https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/nota_tecnica/nota_tecnica_relatorio_de_cobertura_AB.pdf)

Ministério da Saúde. Nota Metodológica. Novo método de cálculo do indicador Cobertura populacional estimada na Atenção Básica. Disponível em:  
[https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20250407\\_O\\_SEI0047071175NT022025CoberturaPotencialEstimadaAPSnosUS\\_7580492751288227022.pdf](https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20250407_O_SEI0047071175NT022025CoberturaPotencialEstimadaAPSnosUS_7580492751288227022.pdf)

#### 1.1.6 Cobertura de Atenção Básica Municipal (AB)

- **Definição:** Percentual da população residente coberta por equipes de Atenção Básica, incluindo equipes de Saúde da Família (ESF) e outras modalidades de equipes de atenção primária.
- **Método de cálculo:** Cobertura de Atenção Básica = (População estimada coberta por equipes de Atenção Básica / população total residente) × 100  
A população coberta é estimada a partir do número de equipes de Atenção Básica cadastradas, considerando parâmetros definidos pelo Ministério da Saúde para população adscrita por equipe.

Método de cálculo:

a) Método anterior (até aproximadamente 2020): A população coberta é estimada a partir do número de equipes cadastradas no SCNES, considerando parâmetros normativos de população adscrita por equipe:

- 3.450 pessoas por equipe de Saúde da Família (eSF)
- 3.000 pessoas por equipe de Atenção Básica equivalente

Fórmula:

$$((n^{\circ} \text{ eSF} \times 3.450) + (n^{\circ} \text{ eAB parametrizadas} + n^{\circ} \text{ eSF equivalentes}) \times 3.000) / \text{população estimada} \times 100$$

b) Método atualizado (Cobertura Potencial Estimada da APS):

Passa a considerar diferentes modalidades de equipes e a população cadastrada no SISAB:

- eSF: 3.500 pessoas por equipe
- eAP 20h: 1.750 pessoas por equipe
- eAP 30h: 2.625 pessoas por equipe
- eCR, eSFR e eAPP: população cadastrada informada

Fórmula:

$$((n^{\circ} \text{ eSF} \times 3.500) + (n^{\circ} \text{ eAP 20h} \times 1.750) + (n^{\circ} \text{ eAP 30h} \times 2.625) + \text{população cadastrada em eCR, eSFR e eAPP}) / \text{população estimada IBGE} \times 100$$

Observação: A mudança metodológica pode impactar a comparabilidade da série histórica.

- **Fonte:** Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – estimativas populacionais. TabNet – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP). Ano de referência: 2020.
- **Qualidade da informação:** os dados são provenientes de sistemas oficiais do Ministério da Saúde e utilizados para monitoramento da Atenção Primária à Saúde. A estimativa de cobertura baseia-se em parâmetros normativos de população adscrita por equipe, podendo não refletir integralmente a cobertura assistencial real. Podem ocorrer inconsistências decorrentes de atrasos na atualização dos cadastros, variações na implantação das equipes ou diferenças na organização local dos serviços.
- **Referências:**  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. e-Gestor Atenção Básica: histórico de cobertura da Atenção Básica. Disponível em:  
<https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml>  
Ministério da Saúde. Nota técnica - relatório de Cobertura da Atenção Básica. Disponível em:  
[https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/nota\\_tecnica/nota\\_tecnica\\_relatorio\\_de\\_cobertura\\_AB.pdf](https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/nota_tecnica/nota_tecnica_relatorio_de_cobertura_AB.pdf)  
Ministério da Saúde. Nota Metodológica. Novo método de cálculo do indicador Cobertura populacional estimada na Atenção Básica. Disponível em:  
[https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20250407\\_O\\_SEI0047071175NT022025CoberturaPotencialEstimadaaAPSnoSUS\\_7580492751288227022.pdf](https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20250407_O_SEI0047071175NT022025CoberturaPotencialEstimadaaAPSnoSUS_7580492751288227022.pdf)

#### 1.1.7 Número de Unidades Básicas de Saúde (UBS)

- **Definição:** número de Unidades Básicas de Saúde (UBS) cadastradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), por município. Para a construção deste indicador, foram excluídos estabelecimentos classificados como equipes de Consultório na Rua (eCR), unidades prisionais (penitenciárias, CDP, CPP, HCTP), hospitais, unidades de pronto atendimento (PA/PAS), serviços móveis e outras unidades que não se caracterizam como UBS.

- **Método de cálculo:** contagem absoluta do número de estabelecimentos classificados como Unidades Básicas de Saúde no CNES, considerando registros ativos no período de referência. A identificação e validação das UBS podem ser complementadas por informações do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Primária à Saúde (SISAPS), especialmente no que se refere à vinculação de equipes e funcionamento das unidades.
- **Fonte:** Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), disponibilizado por meio do e-Gestor Atenção Primária à Saúde e do TabNet da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Primária à Saúde (SISAPS) – informações sobre equipes vinculadas às unidades. Período de referência: 2023–2024.
- **Qualidade da informação:** os dados são provenientes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), sistema oficial do Ministério da Saúde para registro de estabelecimentos de saúde no Brasil. A base apresenta abrangência nacional e é atualizada periodicamente pelos gestores municipais e estaduais. As informações do SISAPS complementam a análise, permitindo identificar a vinculação de equipes às unidades e apoiar a qualificação dos registros, embora não constituam a fonte primária para contagem de estabelecimentos. Podem ocorrer inconsistências relacionadas ao cadastro dos estabelecimentos, como atrasos na atualização, registros duplicados ou classificação inadequada do tipo de unidade.
- **Referências:**  
Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br/>  
Ministério da Saúde. e-Gestor Atenção Primária à Saúde. Disponível em: <https://egestorab.saude.gov.br/>  
Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Primária à Saúde (SISAPS). Disponível em: <https://sisaps.saude.gov.br/>

## 1.2 Estabelecimentos de Referência

- **Definição:** este painel apresenta a organização da rede assistencial de referência para atenção à gestação, parto e acompanhamento neonatal no âmbito da Rede Materna e Neonatal do Estado de São Paulo, considerando as pactuações estabelecidas nos Planos de Ação Regionais (PAR) das Regiões de Redes de Atenção à Saúde (RRAS).

O painel consolida informações sobre os estabelecimentos de referência para diferentes pontos da linha de cuidado materno-infantil, incluindo:

- Ambulatório de gestação e puerpério de alto risco (AGPAR) e maternidade de alto risco de referência (Gestação de alto risco);
- Maternidade de baixo risco de referência – Gestação baixo risco;
- Ambulatório de acompanhamento de crianças de alto risco prioritariamente egressas de unidade neonatal (A-SEG) – Acompanhamento neonatal de alto risco.

As informações são organizadas por RRAS, Região de Saúde e município de residência da gestante, incluindo o estabelecimento de referência, município do serviço e código CNES. O objetivo do painel é permitir a visualização da rede de referência pactuada, apoiando o planejamento regional, o monitoramento da organização da rede assistencial e a análise do acesso aos serviços especializados da Rede.

- **Método de cálculo:** este painel não representa um indicador calculado, mas sim a sistematização das referências assistenciais pactuadas nos Planos de Ação Regionais (PAR) da Rede Materna e Neonatal do Estado de São Paulo.  
A consolidação consiste na padronização das tabelas regionais, identificação dos estabelecimentos de referência, seus respectivos municípios e códigos CNES, e organização dessas informações por RRAS, Região de Saúde e município de residência.
- **Fonte:** Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). Planos de Ação da Rede Alyne – 2025, elaborados pelas Regiões de Redes de Atenção à Saúde (RRAS) do Estado de São Paulo.
- **Qualidade da informação:** a qualidade das informações depende da consistência e completude dos dados registrados nos Planos de Ação Regionais. Durante o processo de sistematização, foi realizada a padronização das tabelas e dos campos, incluindo a identificação de:
  - estabelecimento de referência;
  - município do estabelecimento;
  - código CNES;
  - tipo de referência na linha de cuidado.Eventuais inconsistências ou ausências de informação refletem limitações presentes nos próprios documentos regionais.

- **Referências:**

Brasil. Ministério da Saúde. Rede Alyne – Estratégia Nacional para Qualificação da Atenção Materna e Neonatal.

São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde. Planos de Ação Regionais da Rede Alyne – 2025. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Ministério da Saúde.

## 2. Óbitos de Gestantes e Puérperas

### 2.1 Séries de Mortalidade e Morbidade

#### 2.1.1 Número de óbitos maternos

- **Definição:** número total de óbitos maternos, incluindo os óbitos maternos declarados e os identificados após investigação.  
O número total de óbitos maternos é imprescindível para o cálculo da razão de morte materna, o que pode não ser possível em municípios pequenos (menos de 100.000 habitantes). Para esses municípios, as taxas podem flutuar muito, devido ao pequeno número de ocorrências de óbitos e nascimentos. Recomenda-se, nestes casos, analisá-las agregando-se vários anos e/ou segundo o número absoluto de óbitos<sup>1</sup>.
- **Método de cálculo:** Número total de óbitos maternos após investigação.
- **Fonte:** SIM-DOMAT.
- **Qualidade da informação:** este indicador depende da vigilância do óbito materno. Locais com cobertura de investigação de óbitos de Mulher em Idade Fértil (MIF) abaixo de 90% ou com investigação de óbitos maternos abaixo de 100%<sup>2</sup> devem analisar os resultados desse indicador com cautela.
- **Referências:**

1 [http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sim/Ob\\_Mu\\_Id\\_Fertil\\_Mat\\_1996\\_2012.pdf](http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sim/Ob_Mu_Id_Fertil_Mat_1996_2012.pdf)

2

<http://www.saude.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Pactuacao-Interfederativa-2020-2023.pdf>

### 2.1.2 Razão de Mortalidade Materna (RMM) por 100.000 nascidos vivos

- **Definição:** número de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos em determinado período e local de residência.
- **Método de cálculo:** Razão de Mortalidade Materna (RMM) = (Número de óbitos maternos / número de nascidos vivos) × 100.000  
Para o Estado de São Paulo, foram utilizados os registros de óbitos maternos provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), incluindo a qualificação das informações por meio da vigilância do óbito materno, quando disponível. Embora não seja recomendado o cálculo da RMM para localidades com pequeno número de nascidos vivos, neste painel o indicador é apresentado para diferentes níveis territoriais (Estado, DRS, RRAS, Região de Saúde e municípios), juntamente com o número absoluto de óbitos maternos, com o objetivo de apoiar a análise e identificação de desigualdades regionais.
- **Fonte:** Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP).
- **Qualidade da informação:** este indicador depende da cobertura e qualidade dos dados do SINASC e do SIM, bem como da vigilância e investigação dos óbitos maternos. A subnotificação de óbitos maternos e a classificação inadequada da causa básica de morte podem impactar a estimativa da RMM. Além disso, em áreas com pequeno número de nascidos vivos, o indicador pode apresentar grande variação anual, devendo ser interpretado com cautela. A qualidade da informação também está relacionada ao percentual de investigação dos óbitos de mulheres em idade fértil e à completude das fichas de investigação de óbito materno.
- **Referências:**  
Brasil. Ministério da Saúde. Mortalidade materna nas unidades da Federação, regiões e no Brasil: uma análise de 2000 a 2015. Brasília: Ministério da Saúde; 2017. Disponível em: <https://bit.ly/3fSfjl3>  
Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/>  
Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/>  
Szwarcwald CL et al. Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre

Nascidos Vivos (SINASC), Brasil. Cadernos de Saúde Pública. 2019;35(10):e00214918.  
Brasil. Ministério da Saúde. Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/>

### 2.1.3 Porcentagem de óbitos maternos por causas obstétricas diretas

- **Definição:** percentual de óbitos maternos decorrentes de causas obstétricas diretas, em relação ao total de óbitos maternos em determinado período e local de residência.
- **Método de cálculo:** porcentagem de óbitos maternos por causas obstétricas diretas =  $(\text{Número de óbitos maternos por causas obstétricas diretas} / \text{total de óbitos maternos}) \times 100$   
Foram consideradas como causas obstétricas diretas aquelas classificadas segundo os critérios do Ministério da Saúde, incluindo:
  - causas básicas com CID-10 O00.0 a O08.9, O11 a O23.9, O24.4 e O26.0 a O92.7;
  - causas A34, F53 e M83.0 quando ocorridas até 42 dias após o término da gestação;
  - causas D39.2 e E23.0 quando ocorridas durante a gestação, parto ou até 42 dias após o término da gestação.
- **Fonte:** Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), com qualificação pela vigilância do óbito materno no Estado de São Paulo (SES-SP).
- **Qualidade da informação:** Este indicador depende da qualidade da informação registrada no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e da vigilância do óbito materno no Estado de São Paulo. A classificação correta das causas de morte e a investigação dos óbitos de mulheres em idade fértil são fundamentais para a adequada identificação dos óbitos maternos por causas obstétricas diretas. Baixos percentuais de investigação de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) ou de óbitos maternos podem comprometer a confiabilidade do indicador, devendo os resultados ser interpretados com cautela. Além disso, podem ocorrer inconsistências na definição da causa básica de morte, impactando a distribuição entre causas obstétricas diretas e indiretas.
- **Referências:**  
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica do Óbito Materno. Brasília: Ministério da Saúde; 2009. Disponível em: [https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia\\_vigilancia\\_epidem\\_obito\\_materno.pdf](https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidem_obito_materno.pdf)  
Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Disponível em:

#### 2.1.4 Porcentagem de óbitos maternos diretos por causas específicas

- **Definição:** percentual de óbitos maternos por causas obstétricas diretas distribuídos segundo causas específicas, incluindo aborto, hipertensão, hemorragia e infecção puerperal, em determinado período e local de residência.
- **Método de cálculo:** porcentagem de óbitos maternos diretos por causas específicas =  $(\text{Número de óbitos maternos por causa específica} / \text{total de óbitos maternos por causas obstétricas diretas}) \times 100$

Foram consideradas como causas obstétricas diretas aquelas classificadas segundo os critérios do Ministério da Saúde, incluindo:

- causas básicas com CID-10 O00.0 a O08.9, O11 a O23.9, O24.4 e O26.0 a O92.7;
- causas A34, F53 e M83.0 quando ocorridas até 42 dias após o término da gestação;
- causas D39.2 e E23.0 quando ocorridas durante a gestação, parto ou até 42 dias após o término da gestação.

Para a classificação das causas específicas, foram considerados os seguintes agrupamentos:

- Aborto: causas básicas O03 a O07;
  - Hipertensão: causas básicas O11, O13, O14, O15 e O16;
  - Hemorragias: causas básicas O20, O44, O45, O46, O67, O71.0, O71.1 e O72;
  - Infecção puerperal: causas básicas O85 e O86.
- **Fonte:** Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), com qualificação pela vigilância do óbito materno no Estado de São Paulo (SES-SP).
  - **Qualidade da informação:** Este indicador depende da qualidade dos registros do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e da vigilância do óbito materno no Estado de São Paulo. A correta classificação da causa básica de morte é essencial para a adequada identificação das causas específicas de óbitos maternos diretos. Baixos percentuais de investigação de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) ou de óbitos maternos podem comprometer a confiabilidade do indicador, devendo os resultados ser interpretados com cautela. Além disso, podem ocorrer inconsistências na definição da causa básica, impactando a distribuição entre as diferentes categorias analisadas.

- **Referências:**

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica do Óbito Materno. Brasília: Ministério da Saúde; 2009. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia\\_vigilancia\\_epidem\\_obito\\_materno.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidem_obito_materno.pdf)

Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/>

## 2.2 Oficiais

### 2.2.1 Tabela de Óbitos Maternos Oficiais

- **Definição:** este indicador apresenta o número total de óbitos maternos contabilizados pelo Ministério da Saúde, considerando como unidade de análise o município de residência da mulher. Um óbito de gestante ou puérpera é classificado como óbito materno quando a causa básica de morte, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), pertence a uma das categorias definidas pelo Ministério da Saúde para mortalidade materna. O indicador também permite a classificação dos óbitos segundo o período de ocorrência (gravidez, parto, puerpério) e a informação sobre investigação por Comitê de Morte Materna.
- **Método de cálculo:** O indicador corresponde à contagem absoluta dos óbitos maternos registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), conforme critérios definidos pelo Ministério da Saúde.
- **Fonte:** Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) – Ministério da Saúde, TabNet – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP).
- **Qualidade da informação:** Os dados são provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), que constitui a principal fonte oficial para monitoramento de óbitos no Brasil. A qualidade da informação depende da adequada notificação e investigação dos óbitos, podendo sofrer influência de: subnotificação de óbitos maternos, classificação incorreta da causa básica de morte, inconsistências no preenchimento das variáveis, atrasos na atualização das bases de dados.  
A investigação por Comitês de Morte Materna contribui para a melhoria da qualidade da informação, permitindo maior precisão na classificação dos óbitos.

- **Referências:**

Brasil. Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Disponível em:

[https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/sistemas-de-informacao/sim?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/sistemas-de-informacao/sim?utm_source=chatgpt.com)

Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Vigilância do Óbito Materno. Disponível em:

[https://svs.aids.gov.br/daent/cgiae/coesv/sistemas-informacao/sim/?utm\\_source=chatgpt.com](https://svs.aids.gov.br/daent/cgiae/coesv/sistemas-informacao/sim/?utm_source=chatgpt.com)

Organização Mundial da Saúde (OMS). Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10). Disponível em:

[https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o\\_Estat%C3%ADstica\\_Internacional\\_de\\_Do%C3%A7as\\_e\\_Problemas\\_Relacionados\\_com\\_a\\_Sa%C3%BAde?utm\\_source=chatgpt.com](https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_Estat%C3%ADstica_Internacional_de_Do%C3%A7as_e_Problemas_Relacionados_com_a_Sa%C3%BAde?utm_source=chatgpt.com)

## 2.3 Não considerados

### 2.3.1 Tabela de Óbitos Não Considerados

- **Definição:** Este indicador apresenta o número de óbitos de mulheres ocorridos durante a gravidez, parto ou puerpério tanto no período de até 42 dias após o parto quanto entre 43 dias e menos de um ano que não são classificados como óbitos maternos segundo a definição adotada pelo Ministério da Saúde. O local de registro dos óbitos corresponde ao município de residência da mulher. Incluem-se, entre esses casos, óbitos cuja causa básica não se enquadra nas categorias de mortalidade materna, como aqueles decorrentes de causas externas.
- **Método de cálculo:** O indicador corresponde à contagem absoluta dos óbitos registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) que ocorreram durante a gravidez, parto ou puerpério, mas que não atendem aos critérios de classificação como óbito materno.
- **Fonte:** Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) – Ministério da Saúde, TabNet – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP).
- **Qualidade da informação:** Os dados são provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), que constitui a principal fonte oficial para monitoramento de óbitos no

Brasil. A qualidade da informação pode ser influenciada por: subnotificação de óbitos relacionados à gestação, classificação inadequada da causa básica de morte, inconsistências no preenchimento das variáveis do sistema, atrasos na atualização das bases de dados. A investigação por Comitês de Morte Materna contribui para qualificar a informação, possibilitando melhor distinção entre óbitos maternos e não maternos.

- **Referências:**

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/sistemas-de-informacao/sim>

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de Vigilância do Óbito Materno. Disponível em:

<https://svs.aims.gov.br/daent/cgiae/coesv/sistemas-informacao/sim/>

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10. Disponível em:

<https://www.who.int/classifications/icd/en/>

## 2.4 Análise Cruzada

- **Definição:** Este painel apresenta uma análise cruzada dos óbitos de gestantes e puérperas, permitindo a visualização da distribuição dos casos segundo diferentes características sociodemográficas e assistenciais. A ferramenta possibilita analisar os óbitos por diferentes níveis territoriais estadual, DRS, RRAS, Região de Saúde e município e cruzar variáveis de interesse, como ano do óbito, raça/cor, faixa etária, tipo de causa obstétrica, período de ocorrência do óbito e situação de investigação por Comitê de Morte Materna. Os resultados podem ser apresentados em formato de gráfico e tabela, com distribuição percentual por linha, por coluna ou por célula, conforme seleção do usuário.
- **Método de cálculo:** A análise cruzada é construída a partir dos registros de óbitos de gestantes e puérperas disponíveis no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), organizados segundo os filtros e variáveis selecionados no painel. O usuário pode definir:
  - período de análise;
  - nível territorial de análise;
  - variável da linha;

- variável da coluna;
- tipo de percentual da tabela (por coluna, por linha ou por célula);
- faixa etária;
- raça/cor;
- tipo de causa obstétrica;
- período de ocorrência do óbito;
- tipo de investigação do óbito.

O painel apresenta os valores absolutos e, quando selecionado, os percentuais correspondentes à distribuição dos óbitos nas categorias analisadas.

- **Fonte:** Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) – Ministério da Saúde, TabNet – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP).
- **Qualidade da informação:** A qualidade da análise depende da completude e consistência dos registros do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), especialmente no preenchimento das variáveis utilizadas para os cruzamentos. Os resultados podem ser influenciados por: subnotificação de óbitos, classificação incorreta da causa básica de morte, incompletude das variáveis sociodemográficas, inconsistências no preenchimento das variáveis, diferenças na investigação dos óbitos entre territórios e períodos.  
Como se trata de uma ferramenta analítica de cruzamento de dados, recomenda-se cautela na interpretação de categorias com pequeno número de casos, especialmente em recortes territoriais mais desagregados.
- **Referências:**  
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/sistemas-de-informacao/sim>  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de Vigilância do Óbito Materno. Disponível em:  
<https://svs.aids.gov.br/daent/cgiae/coesv/sistemas-informacao/sim/>  
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10. Disponível em:  
<https://www.who.int/classifications/icd/en/>

### 3. Indicadores Obstétricos

#### 3.1 Partos Prematuros

##### 3.1.1 Nascimentos

- **Definição:** Número total de nascidos vivos registrados no período e local selecionados. Este indicador permite acompanhar a evolução temporal dos nascimentos, conforme apresentado na tabela e no gráfico do painel.
- **Método de cálculo:** O indicador corresponde à contagem absoluta de nascidos vivos registrados no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), segundo o ano de ocorrência e o nível territorial selecionado.  
Os dados apresentados na tabela e no gráfico refletem o total de nascimentos por ano, podendo variar conforme o recorte geográfico adotado (estadual, regional ou municipal).
- **Fonte:** Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – Ministério da Saúde.
- **Qualidade da informação:** Este indicador depende da cobertura do SINASC e da qualidade do registro dos nascidos vivos. De forma geral, o SINASC apresenta elevada cobertura no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. Entretanto, a interpretação dos resultados deve considerar possíveis subregistros, atrasos na inserção dos dados e variações na qualidade da informação entre diferentes localidades e períodos.
- **Referências:**  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativas de sub-registro de nascimentos. Disponível em:  
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html>  
SZWARCWALD, C. L. et al. Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2019; 35(10): e00214918.

##### 3.1.2 Partos Prematuros

- **Definição:** Este indicador apresenta a proporção de nascidos vivos com idade gestacional inferior a 37 semanas, sendo considerado um importante marcador das condições de saúde materna e neonatal. Um parto é classificado como prematuro quando a variável

GESTACAO do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) assume os seguintes valores: 1 (menos de 22 semanas), 2 (22 a 27 semanas), 3 (28 a 31 semanas) ou 4 (32 a 36 semanas).

- **Método de cálculo:** O indicador é calculado a partir da razão entre o número de nascidos vivos classificados como prematuros e o total de nascimentos com informação válida de idade gestacional. São considerados prematuros os nascimentos com idade gestacional inferior a 37 semanas ( $GESTACAO < 5$ ). Não são incluídos no denominador os casos com informação ignorada ( $GESTACAO = 9$ ).

A porcentagem de partos prematuros corresponde ao número de nascidos vivos prematuros dividido pelo total de nascimentos menos os casos sem informação, multiplicado por 100.

- **Fonte:** Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – Ministério da Saúde; TabNet – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP).
- **Qualidade da informação:** Este indicador depende diretamente da cobertura e da qualidade do preenchimento da variável GESTACAO no SINASC. A interpretação dos resultados deve considerar possíveis subregistros de nascidos vivos, incompletude ou inconsistência na variável idade gestacional e diferenças na qualidade do registro entre municípios.

Locais com cobertura do SINASC inferior a 90% ou com incompletude elevada devem interpretar os resultados com cautela.

- **Referências:**  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativas de sub-registro de nascimentos. Disponível em:  
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html>

SZWARCWALD, C. L. et al. Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2019; 35(10): e00214918.

ROMERO, D. E.; CUNHA, C. B. Avaliação da qualidade das variáveis socioeconômicas e demográficas dos óbitos de crianças menores de um ano registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2006; 22(3): 673–681.

### 3.1.3 Partos Cesáreas

- **Definição:** Este indicador apresenta a proporção de nascidos vivos por parto cesáreo em relação ao total de nascimentos com informação válida sobre o tipo de parto. O parto cesáreo é identificado a partir da variável PARTO do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), sendo classificado como cesárea quando: PARTO = 2 (cesárea).
- **Método de cálculo:** A porcentagem de partos cesáreos é calculada a partir da razão entre o número de partos cesáreos e o total de nascimentos com informação válida sobre o tipo de parto. Não são considerados no denominador os casos com informação ignorada (PARTO = 9). Dessa forma, o indicador corresponde ao número de partos cesáreos dividido pelo total de nascimentos menos os casos sem informação, multiplicado por 100.
- **Fonte:** Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – Ministério da Saúde, TabNet – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP).
- **Qualidade da informação:** Este indicador depende da cobertura do SINASC e da qualidade do preenchimento da variável PARTO. A interpretação dos resultados deve considerar: possíveis subregistros de nascimentos, incompletude ou inconsistência na informação sobre tipo de parto, diferenças na qualidade do registro entre municípios e períodos.

Apesar da elevada cobertura do SINASC no Estado de São Paulo, eventuais falhas de preenchimento podem impactar a precisão do indicador.

- **Referências:**  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativas de sub-registro de nascimentos. Disponível em:  
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html>  
SZWARCWALD, C. L. et al. Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2019; 35(10): e00214918.

### 3.1.4 Porcentagem de partos cesáreos

- **Definição:** Proporção de partos realizados por cesariana em relação ao total de nascimentos com informação válida sobre o tipo de parto. Este indicador permite analisar a frequência de cesarianas ao longo do tempo, conforme apresentado no painel.

- **Método de cálculo:** A porcentagem de partos cesáreos é calculada a partir da razão entre o número de partos cesáreos e o total de nascimentos com informação válida sobre o tipo de parto. São considerados partos cesáreos os registros em que PARTO = 2 (cesárea). Não são incluídos no denominador os casos com informação ignorada (PARTO = 9). Dessa forma, o indicador corresponde ao número de partos cesáreos dividido pelo total de nascimentos menos os casos sem informação, multiplicado por 100.
- **Fonte:** Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – Ministério da Saúde.
- **Qualidade da informação:** Este indicador depende da cobertura do SINASC e da qualidade do preenchimento da variável PARTO. A interpretação dos resultados deve considerar possíveis subregistros de nascimentos, incompletude da variável tipo de parto e variações na qualidade da informação entre municípios. A exclusão dos casos sem informação contribui para maior consistência do indicador.
- **Referências:**  
 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativas de sub-registro de nascimentos. Disponível em:  
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html>  
 SZWARCOWALD, C. L. et al. Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2019; 35(10): e00214918.  
 ROMERO, D. E.; CUNHA, C. B. Avaliação da qualidade das variáveis socioeconômicas e demográficas dos óbitos de crianças menores de um ano registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2006; 22(3): 673–681.

### 3.2 Anomalias congênitas

- **Definição:** Proporção de nascidos vivos com registro de anomalias congênitas em relação ao total de nascimentos com informação válida. Este indicador permite analisar a frequência de anomalias congênitas ao longo do tempo, conforme apresentado na tabela e no gráfico do painel.
- **Método de cálculo:** O indicador é calculado a partir da razão entre o número de nascidos vivos com anomalias congênitas e o total de nascimentos com informação válida para essa

variável. Um caso é considerado como anomalia congênita quando a variável correspondente no SINASC indica presença de anomalia (IDANOMAL = 1). Casos com informação ignorada não são considerados no denominador. Dessa forma, a porcentagem de anomalias congênitas corresponde ao número de nascidos vivos com anomalias dividido pelo total de nascimentos menos os casos sem informação, multiplicado por 100. Cabe destacar que essa variável está disponível no SINASC apenas a partir do ano de 2001, não sendo possível realizar análises para períodos anteriores.

- **Fonte:** Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – Ministério da Saúde.
- **Qualidade da informação:** Este indicador depende da cobertura do SINASC e da qualidade do preenchimento da variável relacionada à presença de anomalias congênitas. A interpretação dos resultados deve considerar possíveis subregistros, incompletude da informação e variações na qualidade do preenchimento entre municípios e períodos. Locais com cobertura inferior a 90% ou com elevada proporção de dados ignorados devem interpretar os resultados com cautela.
- **Referências:**  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativas de sub-registro de nascimentos. Disponível em:  
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html>  
SZWARCOWALD, C. L. et al. Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2019; 35(10): e00214918.  
ROMERO, D. E.; CUNHA, C. B. Avaliação da qualidade das variáveis socioeconômicas e demográficas dos óbitos de crianças menores de um ano registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2006; 22(3): 673–681.

### 3.3 Consultas de pré-natal

- **Definição:** Distribuição percentual dos nascidos vivos segundo o número de consultas de pré-natal realizadas pela mãe durante a gestação. O indicador permite analisar a adequação do acompanhamento pré-natal ao longo do tempo, conforme apresentado na tabela e no gráfico do painel.

- **Método de cálculo:** Os nascidos vivos são classificados de acordo com a variável CONSPRENAT do SINASC, agrupada nas seguintes categorias: nenhuma consulta, 1 a 6 consultas e 7 ou mais consultas. O indicador é calculado como a proporção de nascidos vivos em cada categoria em relação ao total de nascimentos com informação válida. Não são considerados no denominador os casos com informação ignorada. A porcentagem de cada categoria corresponde ao número de nascidos vivos na categoria dividido pelo total de nascimentos menos os casos sem informação, multiplicado por 100.
- **Fonte:** Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – Ministério da Saúde.
- **Qualidade da informação:** Este indicador depende da cobertura do SINASC e da qualidade do preenchimento da variável CONSPRENAT. A interpretação deve considerar possíveis subregistros, incompletude da informação e variações na qualidade do preenchimento entre municípios. Locais com cobertura inferior a 90% ou com elevada proporção de dados ignorados devem analisar os resultados com cautela.
- **Referências:**  
 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativas de sub-registro de nascimentos. Disponível em:  
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html>  
 SZWARCOWALD, C. L. et al. Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2019; 35(10): e00214918.  
 ROMERO, D. E.; CUNHA, C. B. Avaliação da qualidade das variáveis socioeconômicas e demográficas dos óbitos de crianças menores de um ano registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2006; 22(3): 673–681.

### 3.4 Robson

- **Definição:** Distribuição percentual dos nascidos vivos segundo os grupos da classificação de Robson (1 a 10), utilizada para análise e monitoramento dos padrões de assistência ao parto.
- **Método de cálculo:** Os nascidos vivos são classificados de acordo com a variável TPROBSON do SINASC, que combina informações sobre paridade, tipo de gestação,

apresentação fetal, idade gestacional, início do trabalho de parto e histórico de cesariana. A porcentagem de cada grupo de Robson é calculada dividindo-se o número de nascidos vivos em cada grupo pelo total de nascimentos, multiplicado por 100.

- **Fonte:** Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – Ministério da Saúde.
- **Qualidade da informação:** Este indicador depende da qualidade do preenchimento das variáveis que compõem a classificação de Robson, incluindo tipo de gestação, apresentação fetal, idade gestacional, tipo de parto e histórico obstétrico. Inconsistências ou incompletudes nessas variáveis podem afetar a classificação dos grupos e a interpretação dos resultados.
- **Referências:**  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativas de sub-registro de nascimentos. Disponível em:  
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html>  
SZWARCOWALD, C. L. et al. Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2019; 35(10): e00214918.  
ROMERO, D. E.; CUNHA, C. B. Avaliação da qualidade das variáveis socioeconômicas e demográficas dos óbitos de crianças menores de um ano registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2006; 22(3): 673–681.

### 3.5 Robson e cesáreas

- **Definição:** Proporção de partos cesáreos em cada grupo da classificação de Robson, permitindo avaliar a contribuição de cada grupo para a ocorrência de cesarianas.
- **Método de cálculo:** Para cada grupo de Robson, a porcentagem de cesarianas é calculada como a razão entre o número de partos cesáreos e o total de nascimentos no respectivo grupo. São considerados partos cesáreos os registros em que PARTO = 2. Casos com informação ignorada são excluídos do cálculo. A porcentagem é obtida dividindo-se o número de cesarianas no grupo pelo total de nascimentos com informação válida no mesmo grupo, multiplicado por 100.
- **Fonte:** Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – Ministério da Saúde.

- **Qualidade da informação:** Este indicador depende da qualidade do preenchimento da variável PARTO e das variáveis que compõem a classificação de Robson. Inconsistências nessas informações podem impactar a correta classificação dos grupos e a estimativa das proporções de cesarianas.
- **Referências:**

SOUZA, J. P. et al. A global reference for caesarean section rates (CModel): a multicountry cross-sectional study. BJOG, 2016; 123(3): 427-436.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativas de sub-registro de nascimentos. Disponível em:  
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html>

SZWARCWALD, C. L. et al. Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2019; 35(10): e00214918.

ROMERO, D. E.; CUNHA, C. B. Avaliação da qualidade das variáveis socioeconômicas e demográficas dos óbitos de crianças menores de um ano registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2006; 22(3): 673–681.